DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO :	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU :	4196722
CALIDAD :	Original	FECHA :	31/07/2025 15:24
AREA :	U.E. Adulto	BOX :	Cama 5
HC :	0	CTA. CTE. :	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : JESSICA DEL CARMEN CATALAN VASQUEZ **RUN** : 11.163.794-6 **CP** : 1013411
Previsión : FONASA B **F.Nac** : 06/06/1966 **Género** : Femenino **Edad** : 59 Años 1 Mes 25 Días
Dirección : SAN FERNANDO 3905 **Comuna** : NIQUEN **Teléfono** : 969190995

DATOS INGRESO:

Procedencia : JOSE DURAN TRUJILLO (CESF **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : AMBULANCIA RURAL

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 31/07/2025 15:25:47;

Profesional : Elizabeth Fierro Palma **Hra. Llamada** : 31/07/2025 15:25 **Hora Atención** : 31/07/2025 15:33
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 0 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 0 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C2
Motivo de consulta: : TRAIDA POR AMBULANCIA DE APS ÑIQUEN DESDE DOMICILIO CON IC MEDICA POR CONVULSION
AM: TRISOMIA 21, ACV SECUELADA, EPILEPSIA, DMNIR
ALERGIAS: NO
PA 106/68 / FC 69 LPM /SAT.95% /HGT 1789 MG/DL
ACOMPAÑADA

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
31/07/2025 15:42	97	125/70	36.3		15	92	155	Carolina Estefany Muñoz Leon
31/07/2025 17:53	75	126/69	36.3		18	97		Carolina Estefany Muñoz Leon

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS:

Fecha	Anamnesis	Profesional
31/07/2025 15:42	am: epilepsia focal con generalización 2ria, ACV isquémicos múltiples antiguos secuelados, Trisomía 21, Déficit intelectual severo, mrs 4, HTA crónica, DM II NIR, Hipotiroidismo, Dislipidemia mixta paciente con antecedentes derscritos traida por hermana quien refiere 3 episodios de mirada fija , movimientos tonico clonicos generalizados de aprox 10 min , ayer durante el dia y hoy durante la madrugada hoy hiporreactiva , con hiporexia por lo que no recibe tratamiento cronico	Gisbel Sanchez Rivero
31/07/2025 18:29	Tac de torax sc: los hallazgos descritos en el parenquima pulmonar podrian estar en relacion a proceso inflamatorio-infeccioso de probable origen bronquial	Gisbel Sanchez Rivero

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional
31/07/2025 15:42	glasgow basal 12 puntos hemodinamia estable piel y mucosas hidratadas sin ictericia llene capilar conservado rr2t ss mp+ con roncus base izq , uma- eeii sin edema neurologico: vigil , consciente , sin asimetria facial neurologico sin focalidad actual	Gisbel Sanchez Rivero

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
31/07/2025 18:03	N39.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	Gisbel Sanchez Rivero
31/07/2025 18:27	J20.9 BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	Gisbel Sanchez Rivero
31/07/2025 18:28	G40.9 EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	Gisbel Sanchez Rivero

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
31/07/2025 15:47	monitorizar	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 31/07/2025 16:03	Carolina Estefany Muñoz Leon
31/07/2025 15:47	apoyar co nrc 1 litro	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 31/07/2025 16:03	Carolina Estefany Muñoz Leon
31/07/2025 15:47	examenes de lab	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 31/07/2025 16:23	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 15:49	levetiracetam 1 gr ev	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 31/07/2025 16:23	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 16:03	Tac de cerebro sc + tac de torax sc	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 31/07/2025 18:29	Valentina de Jesús Medel Bravo Obs:INFORMADO
31/07/2025 18:03	Ceftriaxona 2 gr ev	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 31/07/2025 18:14	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 18:27	Panel viral	Gisbel Sanchez Rivero	Ejecutado el 31/07/2025 19:32	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
31/07/2025 15:48	RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; CK TOTAL ; CK-MB ; E.L.P. ; PCR ; ORINA COMPLETA ; PROTROMBINA ; TTPK ; INR ; GASES VENOSO ; TROPONINA I ;	Gisbel Sanchez Rivero
31/07/2025 16:04	TC CEREBRO SIN CONTRASTE,TC T?RAX ALTA RESOLUCI?N SIN CONTRASTE	Gisbel Sanchez Rivero

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
31/07/2025 18:29	- Hospitalizar en HODOM - Ceftriaxona 2 gr ev cada 24 horas por 6 dias -Azitromicina tab 500mg: 1 comp al dia por 5 dias - Bromuro de ipratropio 3 puff cada 6 horas con a/c por 7 dias - Omeprazol 20mg 1 comp en ayunas por 7 dias - Kine respiratoria - Pendiente rescatar urocultivo y panel viral - control en urgencias sos	Gisbel Sanchez Rivero

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
31/07/2025 18:30	- Ceftriaxona 2 gr ev cada 24 horas por 6 dias - Azitromicina tab 500mg: 1 comp al dia por 5 dias - Bromuro de ipratropio 3 puff cada 6 horas con a/c por 7 dias - Omeprazol 20mg 1 comp en ayunas por 7 dias	Gisbel Sanchez Rivero

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional

31/07/2025 16:23	SE INSTALA VVP NUM 18 ESI EN PRIMERA INTENCION	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 16:24	PACIENTE FEMENINA POSTRADA DEPENDIENTE DE 59 AÑOS CON AM DE HTA, DMNIR, S DOWN, HIPOTIROIDISMO, ACV SECUELADA PARESIA EN HEMICUERPO IZQUIERDO, AQX DE HERNIA UMBILICAL, SIN ALERGIAS REFERIDAS, TTO FARMACOLOGICO POCO CLARO. OH (-). TAB(-). LA USUARIA CONSULTA EN LA UE DERIVADA DESDE CECOF CACHAPOAL TRAS PRESENTAR 3 EPISODIOS CONVULSIVOS TONICO CLONICOS EN HOGAR SIN DURACIÓN Y HORA EXACTA (>10 MIN RFIERE LA HERMANA) EL DÍA DE AYER Y HOY EN LA MADRUGADA. SE RECIBE PACIENTE EN SALA POSTICTAL, VENTILANDO ESPONTANEO. AL CSV SE ENCUENTRA HIPOVENTILANDO, RESTO HDE. AL EX FÍSICO SE ENCUENTRA EN EPISODIO POSTICTAL DE AUSENCIA, GLASGOW 9 PTS(4+2+3), PIEL ROSADA, HIDRATADA INDEMNE BIEN PERFUNDIDA A DISTAL. NORMOCRANEA, YUGULARES PLANAS, TORAX SIMETRICO SIN UMA. ABDI. MOVILIDAD REDUCIDA DE SUS 4 EXTR.	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 16:27	USUARIA CON USO DE PAÑAL, SIN LESIONES GENITALES Y SACRAS. VVP N°18 ESI. ACOMPAÑANTE: CLAUDIA CATALAN/ N° 990796238. PACIENTE SE DEJA EN SALA PARA MNI. IE DIEGO CONTRERAS.	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 18:14	Impresión TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CEREBRO: Pequeños infartos antiguos cerebeloso inferiores derechos. Signos de disminución de volumen cerebral. Pequeños infartos lacunares antiguos de los tálamos y cuerpo del núcleo caudado izqueirdo. Hipodensidad de la sustancia blanca supratentorial, sugerentes de microangiopatía. Infarto antiguo del lóbulo parietal inferior derecho.	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 18:49	TTO FARMACOLOGICO: AAS 100 MG C24H, ATORVASTATINA 40 MG C/24H, BR. IPATROPIO 20 MCG/DOSIS C/8H. ENALAPRIL 10 MG C12H. FAMOTIDINA 40 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 1/2 COMP C12H. LEVETIRACETAM 500 MG 1/2 C12H. LEVOTIROXINA 50 MG C24H. QUETIAPINA 25 MG C24H.	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 20:38	SE RECIBE PACIENTE EN COMPAÑIA DE SU HERMANA . , PACIENTE TRANQUILA , HEMODINAMIA ESTABLE , SE VA A DOMICILIO ACEPTADA POR HODOM PARA CONTINUAR TTO ANTIBIOTICO , SE ENTREGA DOCUMENTACION PERTINENTE Y MEDICAMENTOS , EDUCACION A SU FAMILIAR AL ALTA .GESTORA TRAMITA TRASLADO A SU DOMICILIO.	FRANCISCA NICOLE ACUÑA BRIONES
31/07/2025 20:56	SE RECIBE PACIENTE EN COMPAÑIA DE SU HERMANA . , PACIENTE TRANQUILA , HEMODINAMIA ESTABLE , SE VA A DOMICILIO ACEPTADA POR HODOM PARA CONTINUAR TTO ANTIBIOTICO , SE ENTREGA DOCUMENTACION PERTINENTE Y MEDICAMENTOS , EDUCACION A SU FAMILIAR AL ALTA .GESTORA TRAMITA TRASLADO A SU DOMICILIO.	GLORIA PEREIRA ARAYA

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Domicilio

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600•360•7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

www.hospitalsancarlos.cl
Fono: +56 42 2586130

ORIGINAL: PACIENTE
2640105211158

Gisbel Sanchez Rivero
26.978.181-5